

Применение Севофлурана в хирургии опухолей

ГОЛОВЫ И ШЕИ

Кусаинов Б.Р.

Современная ингаляционная анестезия нашла широкое применение в различных разделах хирургии. В настоящее время в клинической практике наиболее часто используются изофлуран и севофлуран.

Цель исследования

- оценить результаты применения севофлурана в хирургии опухолей головы и шеи.

Пациенты и методы

Исследование выполнено у 84 больных (средний возраст $54,8 \pm 5,2$ года), оперированных в плановом порядке по поводу опухолей головы и шеи в КазНИИ ОиР

Среди проведенных вмешательств преобладали комбинированные операции по поводу новообразований гортани, ротоглотки, дна полости рта, языка, верхней и нижней челюсти, слюнных и щитовидной желез, в том числе с первичной пластикой перемещенным кожно-мышечным лоскутом, а также различные варианты шейных лимфодиссекций. Большая часть пациентов отнесена к III классу ASA. Всем больным проводили комбинированную общую анестезию с ИВЛ. За 30 минут до операции внутримышечно вводили анальгетик периферического действия кетопрофен в дозе 1,5 мг/кг. Премедикация на операционном столе включала внутривенное введение атропина (0,01 мг/кг) и фентанила (0,0015 мг/кг). Введение в анестезию осуществляли пропофолом (2 мг/кг), поддержание анестезии – севофлураном в дозе 1,3 – 1,5 МАК и дробным введением фентанила (0,00075 мг/кг на травматичных этапах операции). Миорелаксанты (дитилин 2 -3 мг/кг) использовали только на этапе интубации трахеи. Средняя продолжительность операций составила 90 ± 25 минут. В динамике регистрировали показатели гемодинамики, пульсоксиметрии и капнометрии, проводили исследование периода ранней постнаркозной адаптации.

Результаты

Во всех случаях отмечали гладкое течение анестезии, стабильные показатели гемодинамики, пульсоксиметрии и капнометрии. На этапе индукции анестезии регистрировали снижение уровня САД на $18 \pm 3,5\%$ по сравнению с исходным уровнем, $p < 0,05$. На последующих этапах анестезии отмечали устойчивые показатели ЧСС и САД в пределах безопасного уровня. Средний расход фентанила для поддержания анестезии составил 0,0015 мг/кг. Дополнительного использования миорелаксантов, транквилизаторов и гипотензивных препаратов не требовалось. Высокая управляемость анестезии на основе севофлурана обеспечивала быстрое постнаркозное пробуждение. Восстановление самостоятельного дыхания отмечали через $6 \pm 2,2$ минут после окончания операции, кашлевого рефлекса – через $9 \pm 3,0$ минут, сознания – через $11 \pm 2,5$ минут. Экстубацию трахеи проводили после санации верхних дыхательных путей на фоне восстановления адекватного дыхания. При оценке активности ЦНС через 10 минут после экстубации трахеи по тесту Bidway получены следующие данные: у 69 (82,1%) больных – 0 баллов, у 10 (11,9%) – 1 балл и у 5 (6%) больных – 2 балла. В течение анестезии и

Осы зерттеулер мақсат, тамақ булау анестетиктарының қолдануды клиникалық тәжірибенің бағасы бас және мойынның ісіктері бар емделушілерінде болып табылды. Емделушілер көбінесе ASA бойынша III және II сыныпқа жатқызған. Барлық жағдайлардағы гемодинамиктер, пульсоксиметрия және капнометрия жансыздандыруды тегіс ағым, тұрақты көрсеткіштерді белгіледі. Ортақ жансыздандыруды адекваттылық, басқарылу және қауіпсіздік, дербес тыныстың тез қалпына келтіруімен және қорғайтын рефлексстердің қамтамасыз етеді бас және мойынның ісігінің хирургиядағы севофлуранасы қолдану.

Целью данного исследования, являлась оценка клинического опыта применения ингаляционных анестетиков у пациентов с опухолями головы и шеи. Большая часть пациентов отнесена к III и II классу по ASA. Во всех случаях отмечали гладкое течение анестезии, стабильные показатели гемодинамики, пульсоксиметрии и капнометрии. Применение севофлурана в хирургии опухоли головы и шеи обеспечивает адекватность, управляемость и безопасность общей анестезии, с быстрым восстановлением самостоятельного дыхания и защитных рефлексов.

Objective of this research, the estimation of clinical experience application inhalation anashtesia at patients with head and neck tumors was. The most part of patients is carried to III and to II class on ASA. Bo all cases marked a smooth current of anesthesia, stable indicators of haemodynamics, pulsemetrition and cupnometrition. Application sevofluran in surgery of a tumor of a head and a neck provide adequacy, controllability and savety the general anesthesia, with fast restoration of independent breath and protective reflexes.

раннего постнаркозного периода не отмечено серьезных осложнений, связанных с применением севофлурана. Синдром послеоперационной тошноты и рвоты выявлен у 4 (4,8%) больных с манифестацией через 1-2 часа после окончания операции. Всем пациентам назначали комплексное послеоперационное обезболивание (внутримышечное введение кетопрофена по 100 мг 2 раза в сутки трамадола по 100 мг 3 раза в сутки). В послеоперационном периоде 8 (9,5%) больных в течение суток наблюдались в реанимационном отделении. 76 (90,5%) пациентов после операции находились в палате пробуждения в течение 2-3 часов с последующим переводом в хирургическое отделение, что значительно снизило затраты на лечение.

Вывод

Применение севофлурана в хирургии опухолей головы и шеи обеспечило адекватность, безопасность и управляемость общей анестезии, минимальную потребность в наркотических анальгетиках и миорелаксантах, быстрое пробуждение с восстановлением самостоятельного дыхания и защитных рефлексов.